



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : على مخيمر على بخيت
المحافظة : الجيزة
الحى / المدينة : الدقي
رقم البطاقة : 26306082101331 رقم التليفون : 01021805694
العنوان : اولاد علام
العمر (تاريخ الميلاد) : 08-06-1963 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 26-09-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : ورم خبيث بالبروستاتا
نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : ورم خبيث بالبروستاتا
خطة العلاج : أورام كيماوي علاج الالم ومضادات القئ لمرضي الاورام المنتشر قسم العلاج :
[14456]
التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان
الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: علي مخيمر علي بخيت National ID: 26306082101331	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

A patient of prostate cancer for Pin Medication And Anti Emetics
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

على
مخير على بخيت
٢٥ اولاد علام
الدقى - الجيزة

١٩٦٣/٠٦
٢٦٣.٠٦.٠٨٢١.٠١٣٣١

LR3605888

٢٠٢٦/٠٣ ٢٦٣.٠٦.٠٨٢١.٠١٣٣١

محامي حر

مسلّم

متزوج

ذكر

البطاقة مارية حتى ٢٠٢٢/٠٣/١١

١

Pathology Unit

7144 السن : 63

تاريخ الحضور : 24-02-2026

تاريخ الاستلام : 28-02-2026

فرع : B-Dokki

إسم المريض : علي مخيمر علي بخوت

محول من أ.د : أحمد سعيد

رقم الزيارة : 37126503787/69/72/70/73/71

NATURE OF SPECIMEN:

U/S guided sextant prostatic core biopsy.

GROSS:

Six biopsies were received: (1) Base-Rt. (2) Mid prostate-Rt. (3) Apex Rt. (4) Base-Lt. (5) Mid prostate-Lt. (6) Apex, Lt. Cores are 1.4-1.9 cm, long.

MICROSCOPY:

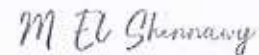
All samples show an invasive acinar carcinoma formed of fused glands that appear to form focal cribriform masses. These glands are not separated by stroma. Other areas show files invading the stroma. There is moderate anaplasia with scattered mitotic activity. There is evidence of perineural invasion. Picture is that of adenocarcinoma, Gleason's score 9 (4+5). WHO grade group 5.

DIAGNOSIS:

Prostate gland, U/S guided sextant core biopsy: Adenocarcinoma, Gleason's score 9 (4+5), Grade group 5 (ISUP/WHO grading system for prostatic carcinoma).



Dr. Habiba Elfendy



Dr. Mohamed El Shenawy

Authentication Date: 28-02-2026

Imaging report



كايرو سكين
للأشعة والتصوير
CAIRO SCAN
Radiology & LASS

Pat. Name: Ali Mekhemer Ali Bekhit	Pat. ID: 3490946
Procedure Name: Gallium 68 PSMA PET-CT	Date: 04/02/2026

Whole body 18-F-PSMA PET/CT EXAMINATION:

Clinical History:

- 53 years old male patient diagnosed with prostatic enlargement, elevated PSA level on hormonal therapy.
- PET/CT requested for assessment.

Technique:

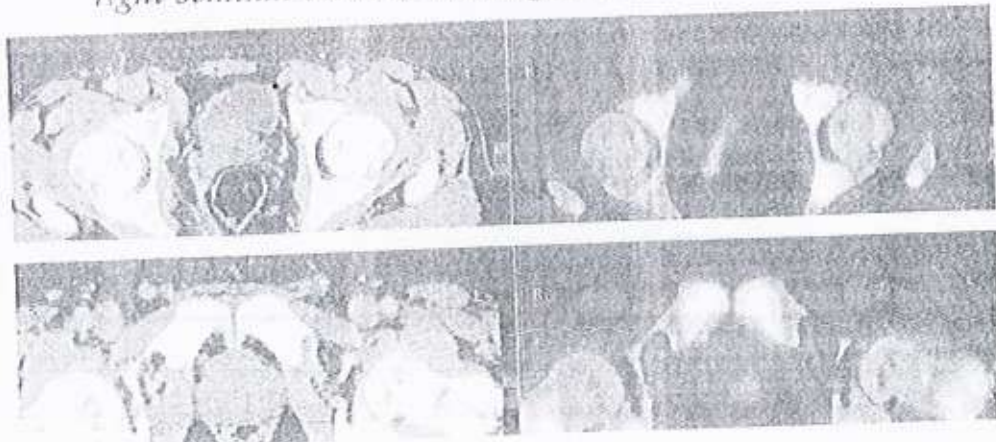
- Whole body 18F-FDG images from skull to mid thighs with the arms extending above the head were obtained.
- CT was acquired for the purpose of anatomic localization and attenuation correction. Data was processed and displayed according to departmental protocol.



Report:

Loco-regional:

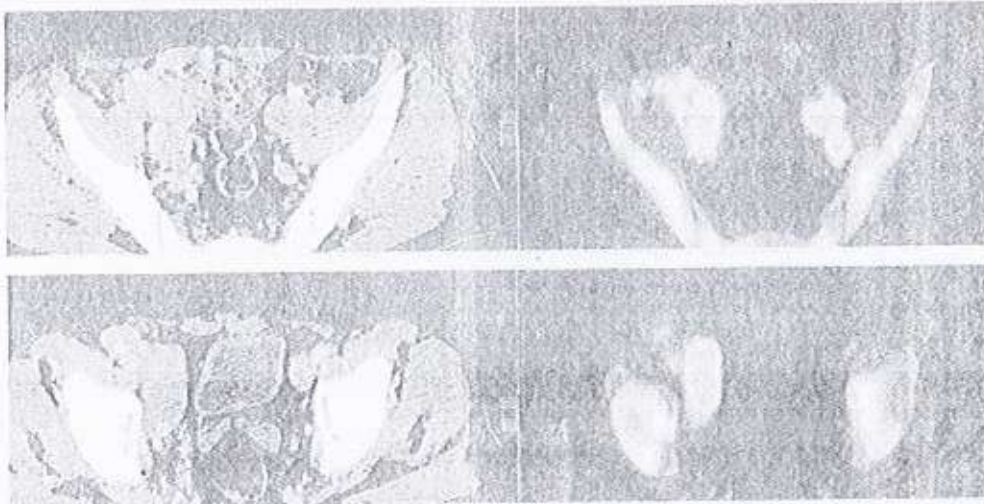
- Enlarged prostate seen indenting urinary bladder base showing multicentric PSMA avid focal lesions extending to right seminal vesicle, showing SUVmax~9.9.





Imaging report

- Extensive PSMA avid pelvic nodal deposits involving all groups, largest seen at right external iliac measuring 5.2x2.7 cm with SUVmax~27.3.



Distant:

- PSMA avid left lower deep cervical and left supra clavicular LNs, reaching 2.9x1.9 cm with SUVmax~11.3.



- PSMA avid multiple mediastinal bilateral hilar, para-aortic, retro caval, and sub carinal LNs, reaching 1.9 cm with SUVmax~18.0.



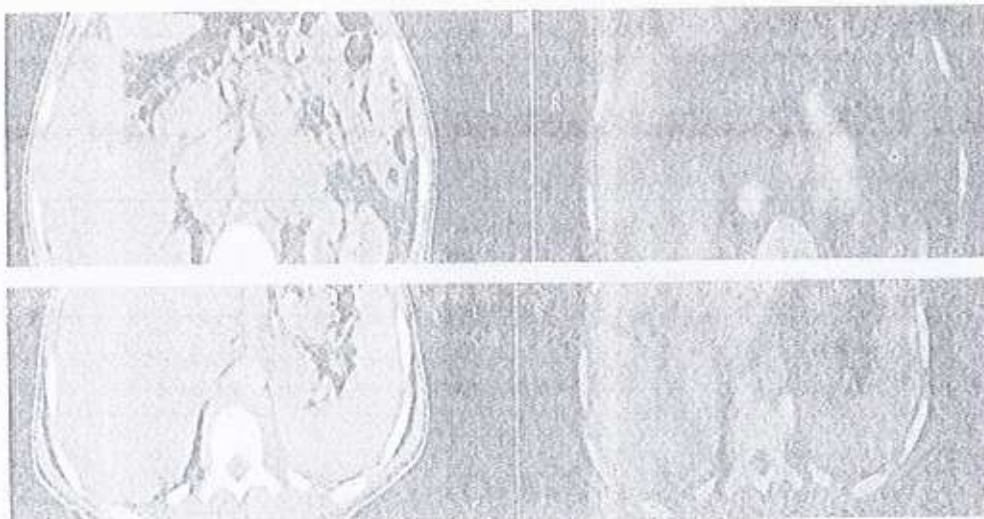
- Multiple PSMA avid abdominal LNs involving multiple para-aortic, aorto caval, retro caval, retro crural, mesenteric, bilateral common iliac LNs, reaching 4.5x3.5 cm with SUVmax~16.7.



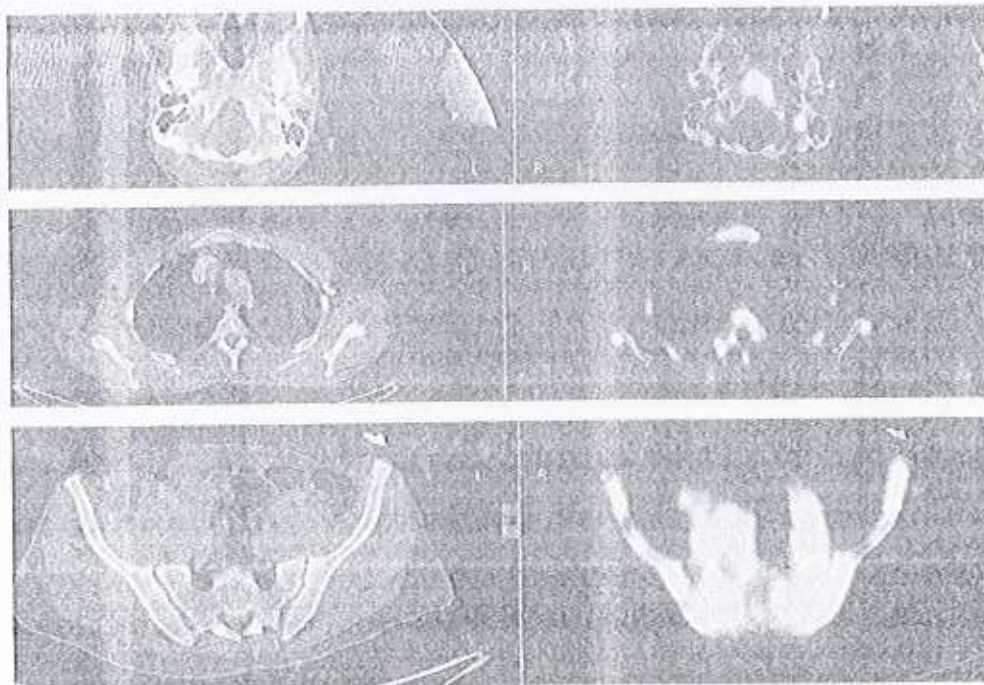
كايرو سكين
التصوير والتشخيص
CAIRO SCAN
Radiology & UMS



Imaging report



- Extensive PSMA avid axial and appendicular PSMA avid osseous deposits, involving skull bones, multiple dorso lumbar vertebrae, both humeri, both femora and right tibia with SUVmax~23.5, recorded over pelvic bones.





Imaging report



كايرو سكين
CAIRO SCAN
Radiology & LASS



Head and Neck:

- * No PSMA avid nasopharynx, oropharynx, salivary glands and larynx focal lesions.
- * No PSMA avid neck soft tissue mass lesions.

Chest:

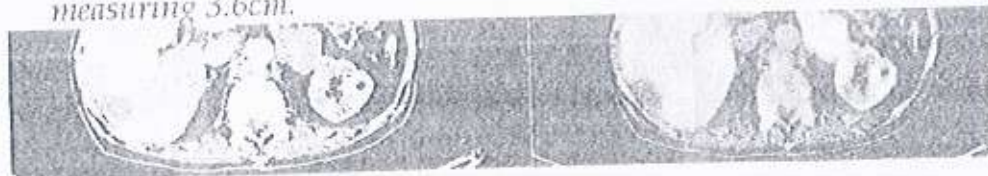
- * Few PSMA avid bilateral lung nodules, reaching 9mm with SUVmax~8.1.



- * No hypermetabolic axillary lymphadenopathy.
- * No metabolically active pericardial or pleural lesions detected.

Abdomen and Pelvis:

- * Physiologic diffuse PSMA uptake is seen over average sized liver with homogenous parenchymatous texture.
- * Non PSMA avid two right hepatic hypodense focal lesions seen at segment V measuring 3.6cm.





- * Physiologic diffuse PSMA uptake is seen over average size spleen with homogenous parenchymal texture and no PSMA avid focal lesions seen.
- * Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes. Physiologic PSMA excretion is seen in the kidneys and bladder.
- * No PSMA avid ascites or abdominal collections noted.

Conclusion:

- PSMA avid multicentric prostatic neoplastic focal lesions associated with extensive metastatic nodal (left cervical, supra clavicular, mediastinal, abdomino pelvic), pulmonary as well as axial and appendicular osseous deposits.

Thank you for referral

Sincerely yours,

Dr. Mariam Ali, MSc
Nuclear Medicine Specialist
NCI, Cairo University

Dr. Esraa El-Kholy, MD
Prof. of Nuclear Medicine
NCI, Cairo University

For any inquiries regarding the findings in the report please contact us on

radreport@cairoscan.com.eg



النقابة العامة للمحامين
مشروع الرعاية الصحية
للمحامين وأسرهم

شهادة

تشهد النقابة العامة للمحامين بأن الأستاذ / علي مخيمر علي بخيت المحامي
رقم القيد / ٩٤٩٩٤

غير مشترك بمشروع العلاج بالنقابة العامة للمحامين ولم يتم الاستفادة منه لهذا
العام ٢٠٢٦ .

وذلك

لتقديمها لأي جهة يرغب بها دون أدنى مسئولية على النقابة العامة للمحامين .

عضو المجلس

التوقيع /

التاريخ / ٢٠٢٦/٦/٢٠

